醫史學 제12권 제1호(통권 제22호) 2003년 6월
ⓒ大韓醫史學會

Korean J Med Hist 12 : 34 – 53, June 2003
ISSN 1225 – 505X

메이지 일본에서 근대적 위생의 형성 과정, 1868 – 1905[1]

이종찬*

1. 들어가는 말: 개념과 방법

메이지(明治) 시대 일본에서 근대적 위생이 어떻게 형성되었는지를 탐구하려면, 무엇보다도 19세기 서구 사회에서 발달되었던 역사적 경험에 대한 두 가지 이해를 전제로 한다. 하나는 근대적 위생에 대한 개념적 이해이며, 다른 하나는 세균설과 근대적 위생의 연관성에 대한 방법론적 이해이다.

근대적 위생이라는 개념은 서구 근대 국가의 역사적 산물로 이해되고 있다. 18세기 중상주의 시대에 등장했던 의사경찰(醫事警察, Medizinal polizei)[2]은 근대적 위생의 선구적 개념이다.[3] 당시 오스트리아가 통치했던 프러시아 지방의 프랑크(Johann P. Frank, 1745 – 1821)[4]가 주창했던 의사경찰의 이론과 방법은 절대 국가의 통치를 위해 매우 요긴하였다.

* 아주대, 하버드大, 醫史學

1) 이 연구를 할 수 있도록 연구 환경을 제공해준 하버드대학교 과학사학과의 Allan Brandt 교수, Bridie Andrews 교수, 옌칭 도서관 한국분관의 윤충남 관장에게 감사를 드린다. 그리고 익명의 평자들에게도 고마움을 표한다.

2) George Rosen. From Medical Police to Social Medicine. New York: Science History Publications 1974. 특히 What Is Social Medicine? (이종찬 편저. 서양의학의 두 얼굴. 서울: 한울; 1992. pp.113 – 85); Henry E. Sigerist. Landmarks on the History of Hygiene(1954). 다섯 가지 사건으로 본 서양보건의학사. 이종찬 옮김. 서울: 한울; 1997. pp.85 – 106.

3) Dorothy Porter. Health, Civilization and the State: A History of Public Health from Ancient to Modern Times. London: Roultledge 1999. pp.52 – 4; George Rosen. A History of Public Health(1958). Expanded ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993; Henry E. Sigerist. 앞의 책. pp.85 – 106.

4) 1750년에 오스트리아의 통치자였던 마리아 테레사(Maria Theresa)는 폰 쥐스티(Heinrich Gottlob von Justi, 1717 – 1771)에게 새로운 학문인 '경찰학'을 가르칠 수 있도록 했으며, 비엔나 대학에서는 폰 존넨펠스(Joseph von Sonnenfels, 1732 – 1817)에게 경찰학 강좌를 허용했다. 폰 존넨펠스는 1765년에 쓴 《Grundsatze der Polizey, Handlung und Finanz》(경찰학 개론)에서 경찰학이 공중보건의 문제를 다루어야 한다고 주장했다. 이 두 사람뿐만 아니라 철학자인 올프(Christian Wolff, 1679 – 1754)도 프랑크에 큰 영향

미셸 푸코가 말한 대로, 생산력이 있는 인구를 관리하기 위해, 정부는 새로운 통치 기술(governmentality)을 필요로 했으며 의사경찰은 바로 그러한 기술에 해당하였다.[5] 산업화가 본격적으로 진행되면서, 유럽 사회는 근대 국가의 제도적 틀을 점점 갖추어 갔고 공중 보건은 근대 국가의 형성에 중요한 역할을 맡게 되었다.[6] 영국의 공중 보건 개혁가로서 공리주의 철학자인 벤담(Jeremy Bentham)의 친구이기도 했던 에드윈 채드윅(Edwin Chadwick)의 유명한 보고서인 『영국 노동 계층의 위생 상태에 관한 보고서』[7] 근대 국가가 인구를 효율적으로 관리하는데 있어서 공중보건의 이론과 방법은 효율적인 수단을 제공할 수 있었다.

파스퇴르(Louis Pasteur, 1822－1895)[8]와 코흐(Robert Koch, 1843－1910)[9]로 대변되는 과학적 의학의 정립은 서양의학의 패러다임을 완전히 바꿔놓았다. 코흐가 1882년에 결핵의 원인이 되는 세균을 '발견'한 것으로 역사를 기술한다면, 그것은 휘그적(Whiggish)인 입장에서 본 것이다. 그는 새로운 질병을 '발명'한 것이다. 실험 의학의 창시자였던 베르나르(Claude Bernard, 1813－1878)가 과학적 의학의 전당이라고 불렀던 실험실에서 그가 수행했던 작업은 단순히 실험 기법상의 혁신이 아니라 '논리적, 철학적, 역사 편찬적'인[10] 문제 영역이었다. 실험 의학을 통해 결핵에 관한 지식을 구성함으로써, 코흐 이전의 결핵은 이후의 결핵과 메꿀 수 없는 간극이 생겨났다. 양자간에 공약불가능성(incommensurability)이 형성되는 것이다. 여기서 한걸음 더 나아가 1880년대 본격적인 궤도에 올랐던 파스퇴르와 코흐의 실험 작업의 방법론적 차이를 이해할 때,[11] 메이지 제국의 의학자들이 왜 파스퇴르가 아닌 코흐의 실험 의학을 제국의 의학에서 모델로 삼았는지를 알게 된다. 파스퇴르는 감염성 질환이 어떻게 발생하며 몸은 질병에 대한 면역성을 어떻게 형성하는지를 규명하였던데 반해, 코흐는 박테리아의 배양을 통해 환경 위생의 개선을 위한 과학적 원리를 정립하는데 몰두했다. 물론, 양자의 방법이 결합될 때, 감염성 질환을 더욱 효과적으로 감소시킬 수 있지만, 파스퇴르는 예방 접종에, 코흐는 환경 위생에 일차적인 관심을 두었다. 메이지 제국의 의학

을 미쳤는데, 그는 군주와 백성의 관계를 가부장적인 관계, 즉 아버지와 자녀의 관계로 규정했다. Johann P. Frank. System einer vollstandigen medicinischen Polizey(1786). A System of Complete Medical Police. Selected trans. Baltimore: Johns Hopkins University 1976. pp.xv－xvi.

5) Michel Foucault. Governmentality. eds by Graham Burchell, Colin Gordon, & Peter Miller. The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: The University of Chicago Press 1991. pp.87－104.

6) Dorothy Porter(ed.). The History of Public Health and the Modern State. Clio Medica 1994;26.

7) Edwin Chadwick. Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Classes of Great Britain(1842). ed by Michael W. Flinn. Edinburgh: Edinburgh University Press 1965.

8) 파스퇴르에 대한 가장 탁월한 평전으로는 Patrice Debre. Louis Pasteur(1994). Louis Pasteur. translated by Elborg Forster. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1998.

9) 코흐에 대한 가장 뛰어난 평전으로는 Thomas D. Brock. Robert Koch: A Life in Medicine and Bacteriology. Washington, D.C.: ASM Press 1999을 볼 것.

10) Andrew Cunningham. Transforming Plague. eds by Andrew Cunningham & Perry Williams. The Laboratory Revolution in Medicine. Cambridge: Cambridge University Press 1992. pp.209－44. p.242.

11) Paul Weindling. Scientific Elites and Laboratory Organization in fin de siecle Paris and Berlin: The Pasteur Institute and Robert Koch's Institute for Infectious Disease Compared. 앞의 책. pp.170－88.

자들은, 코흐의 방법론이 파스퇴르이 그것보다 과학적이어서가 아니라, 전자가 후자보다 제국의 요구를 더욱 충족시켜줄 수 있다고 보았기 때문에 코흐를 선택한 것이다.

서구 근대 국가의 형성 과정에서 정립되었던 위생론은 세균학에 의해 과학적 근거를 갖게 됨에 따라, 서구적 근대를 추종했던 메이지 통치자와 의학자들은 과학적 위생론을 적극적으로 수용하려고 한 것이다.

이런 두 가지 인식을 전제로 한, 이 글의 목적은 위생의 근대성이 메이지 유신 이후 러·일 전쟁에 이르기까지 일본 제국에서 어떻게 형성되었는지를 탐구하는데 있으며, 다음과 같이 네 가지 문제를 다루려고 한다. 첫째, 이 논문은 메이지 통치자들이 일본의 위생 상태를 어떻게 파악하고 있었으며 이를 어떻게 관리했는지를 파악하려고 한다. 둘째, 이 글은 제국의 의학자들이 독일의 근대적 위생학을 배우고 돌아와 자신들의 의학적 세계관을 어떻게 실천해나갔는지를 분석할 것이다. 셋째, 이 연구는 근대적 세균설이 제국의 통치와 팽창에 어떻게 도구적으로 이용되었는지를 조명하려고 한다. 마지막으로, 일본의 군진(軍陣) 위생이 러·일 전쟁에서 어떻게 전략적 수단으로 활용되었는지를 살펴보려고 한다.

2. 제국과 근대적 위생

메이지가 유신을 단행하자마자, 유럽과 미국에 파견했던 이와쿠라(岩倉) 사절단(1871 – 1873)이 서구의 이런 흐름을 놓칠 리 없었다. 의사로서 시찰단의 일원이었던 나가요 센사이(長專 , 1838 – 1902)는 독일어인 'Gesundheitpflege'를 접하게 되었고, 귀국 후, 1873년에 문부성에 위생 관련 부서를 설치할 때, 그는 이 개념을 일본어인 '에이세이'(えいせい)로 번역하였다. 나가요는 중국 사상가인 장자가 쓴 글에서 이 단어를 발견했다고 한다.[12]

그런데, 독일어로부터 번역된 위생의 개념이 메이지 제국을 형성하는데 어떻게 기여했는지를 살펴볼 필요가 있다. 다시 말해서 일본 사회 내부에서 근대적 위생이 어떻게 정립되었는지에 대한 역사적 이해를 위해서 먼저 일본사립위생회(日本私立衛生會)의 활동을 알아본 다음에, 메이지 통치자들이 당시에 직면하고 있었던 일본의 위생 문제를 어떻게 해결해 갔는지를 분석하기로 한다.

최초의 비정부기구로서 1883년 5월에 조직되었던 일본사립위생회가 중요한 이유는, 이 단체가 주도했던 위생 개혁 운동이 제국이 지향하는 위생적 근대화의 방향을 명확하게 보여주기 때문이다. 이 단체의 목표는 "일본 국민의 건강과 삶을 보존하고 향상시키기 위한 방법을 토론하고 연구하며, 위생 지식을 대중화하고, 위생 행정을 지원하는데"[13] 있었다. 이 단체는 당시 일본에 창궐했던 두창을 예방하기 위한 접종을 실시했다. 당시 메이지 개혁가들은 이 단체의 운동 목표를 충분히 알고 있

12) M. H. Fukuda. Public Health in Modern Japan: From Regimen to Hygiene. ed by Dorothy Porter. 앞의 책. pp.385 – 402. p.385에서 재인용.

13) 大日本私立衛生會. 本會規則 摘要. H. Saitoh. The Hygiene Movement in Japan during the Mid – Meiji Period: the Ideological Structure of the Early Movement. Proceedings of the 13th International Symposium on the Comparative History of Medicine – East and West. History of Epidemiology 1988; pp.137 – 160. p.140에서 재인용.

었을 뿐만 아니라, 적극적으로 이 단체에 참여하였다. 이 단체는 1883년에 전염병연구소를 설립했는데, 코흐와 함께 1885년부터 세균학 연구를 수행하였던 키타사또 쉬바사부로(北里紫三郎, 1853－1931)가 이 연구소의 소장으로 취임하였다. 그는 코흐의 실험실을 모델로 삼아 연구소를 운영해갔다. 『문명론의 개략』(文明論之概略)14)(1875)을 써서 일본제국주의의 이론적 기초를 탄탄하게 제공한 것으로 평가되는 후쿠자와 유키치(福澤諭吉, 1834－1901)15)는 나가요 센사이와 오가타쥬구(緒方塾)16)에서 난학(蘭學)을 함께 배웠기에 이 연구소를 설립하는데 재정적으로 지원했으며, 이 단체의 자문관으로 활동했다.

일본사립위생회가 추구했던 위생 개혁 운동의 방향은 크게 세 가지였다.17) 우선, 위생은 제국의 부국과 안전 보장에 공헌해야 했다. 이는 마치 프러시아가 민족국가로서의 단결을 확고히 하기 위해 위생개혁을 국가 정책의 일환으로 추진한 것과 맥을 같이 한다.18) 이 단체의 초대 회장으로서 일본 적십자사를 창설했던 사노 추네타미(佐野常民, 1823－1902)는 일본이 구미 국가들보다 잘 살지 못하는 이유를 일본 사람들이 신체적으로 그들보다 작고 건강하지 않기 때문이라고 보았다.

> 일본 사람의 노동이 유럽 사람의 그것보다 얼마나 뒤떨어져 있는지를 알려면, 일인당 년간 소득을 비교해보면 가장 잘 알 수 있다. 영국은 일인당 년간 소득이 11 달러, 프랑스가 17 달러, 프러시아는 7 달러, 오스트리아는 8 달러, 이탈리아는 10 달러, 벨기에는 10달러이다. 그러나, 일본은 2 달러도 되지 않는다.... 이렇게 일본이 유럽 나라들보다 일인당 년간 소득이 낮은 이유는 일본 사람들의 기본 재산이 적기 때문이며, 재산이 적은 이유는 노동이 부족하기 때문이며, 노동이 부족한 이유는 몸이 허약하기 때문이다.19)

사노 뿐만 아니라, 당시 메이지 제국을 건설하는데 참여했던 지식인들은 일본이 잘 살기 위해서는 신체적으로 건강해야 한다는 점에 모두 동의했다. 그들은 개인의 몸을 국가를 구성하는 개별적인 요소로 파악하면서, 국가의 부를 증강하기 위해선 개인의 건강을 향상시켜야 한다고 보았다.20) 이처럼, 일본이 유럽과 경제적으로 어깨를 겨누려면, 위생 개혁은 선결되어야 할 문제로 인식되었다.

다음으로, 일본사립위생회는 위생 개혁은 근대화가 초래하게 될 부작용을 해소하는데 매우 필요한 조치라고 파악했다. 나가요는 서구 문명이 일본 사회에 점점 확산되면, 문명의 부작용이 나타나게 되는데, 질병의 발생도 부

14) 문명론의 개략. 정명환 옮김. 서울:홍성사; 1986.
15) Yukichi Fukuzawa. The Autobiography of Fukuzawa Yukichi(1899). trans. Tokyo: The Hokuseido Press 1934. p.82.
16) 네델란드 의학을 배웠던 오가타 코안(緒方洪庵, 1810－1863)이 난학을 가르치기 위해 세운 학교였다.
17) H. Saitoh. 앞의 글.
18) Richard H. Shryock. The Development of Modern Medicine: An Interpretation of the Social and Scientific Factors Involved(1936). Madison, W.I.: The University of Wisconsin Press 1974. p.236.
19) 日本私立衛生會誌 1883;1:4. H. Saitoh. 앞의 글에서 재인용.
20) William Johnston. The Modern Epidemic: A History of Tuberculosis in Japan. Cambridge, MA: Harvard University Press 1995. p.295.

작용 중의 하나라고 보았다. 그래서, 후쿠자와는 일본 사람들은 모두 위생에 관한 서구의 책만을 읽어야 한다고 주장했다. 근대적 위생 개혁은 서구 문명이 야기하는 악영향을 해결할 수 있다는 것이다. 위생은 근대성을 성취하기 위한 진보의 도정에서 모든 악을 척결하게 될 것이다.

이 단체가 마지막으로 추구했던 운동의 방향은 일본인의 생활 양태를 개선하는데 있었다. 일본 해군의 각기병을 척결하는데 크게 공헌했던 타가키 가네히로(高木兼寬, 1849－1920)은 일본 사람이 일상적으로 먹는 음식에 주목하였다. 그는 유럽 사람과 일본인의 신체를 비교하면서, 영양 상태를 바꾸어야 일본인의 몸이 유럽 사람처럼 될 수 있다고 역설했다. 이 단체에 참여했던 다른 개혁가들은 신발과 옷들을 비롯하여 모든 종류의 전통적인 생활 습관을 근대적 위생의 관점에서 비판하면서, 일본인들은 유럽의 생활 습관에 적응해야 한다고 주장하였다. 그렇게 되면, 일본 사람의 몸은 유럽 사람의 몸처럼 되어, 유럽과 동등한 수준에 올라갈 수 있을 것이다.

3. 메이지 시대의 생체정치(Biopolitics)

1880년대는 메이지 제국의 법률 제도와 마찬가지로 국가 의료 제도가 실질적으로 확립된 시기였다.[21] 그래서 일본 제국의 내무성에 속한 위생국(衛生局)이 1880년부터 발간된 연간 통계 보고서를 연도별로 살펴보면, 제국의 위생 상태와 정책이 연도별로 어떻게 변해갔는지를 잘 보여준다. 제국이 처한 국내적·국제적 상황의 변화에 따라 연간 보고서의 형식과 내용이 지속적으로 변화하고 있다. 1881년에 발간된 보고서만 하더라도, 보고서의 제목이 시사하듯이, 제국의 인구를 관리하기 위하여 보건 통계의 가장 기초적 자료에 해당하는, 일본인의 출생, 결혼, 사망에 관한 기초적 통계만을 포함하고 있는데, 제국의 위생에 관한 기본 통계인 연령별 사망률, 질병별 사망률, 지역별 전염병 발생률과 사망률, 지역별 접종률 등이 상세하게 도표로 나와 있다.[22] 특히, 1879년에 발생한 콜레라에 대해, 지역별·연령별 발생건수와 사망자 수를 기록하고 있는데, 151,287건의 발생에 대해 51,911건을 치료했으며 99,376명(남자 54,673명과 여자 44,703명)이 사망한 것으로 보고되고 있다. 콜레라 이외에도, 장티푸스, 이질, 디프테리아, 두창, 발진티푸스 등에 대해서도 같은 분석 자료를 기록하고 있다.

이처럼, 기초적인 보건통계만 보여주던 위생국의 연간 보고서는, 1880년대 중반기 제국의 위생 상태에 관해 기록하고 있는 1890년도 보고서(위생국장 나가요 센사이)에서는 인구의 변동에 관한 기초 자료뿐만 아니라, 위생국이 일본 제국의 위생 수준을 향상시키기 위해 구체적으로 어떤 방법을 강구하고 있는지를 설명하고 있다.[23]

<표 1>이 보여주듯이, 1885년과 1886년에 콜레라 등 몇몇 전염병이 크게 창궐하자, 제국주의자들은 총력을 기울여서 방제 작업에 막대한 비용과 노력을 기울였던 것으로 보인다.

21) 가라타니 고진(柄谷行人). 일본 근대문학의 기원. 박유하 옮김. 서울: 민음사; 1997. p.148.
22) 衛生局(Sanitary Bureau). Statistical Tables of Births, Marriages, Deaths, etc, etc. Tokio. 1881.
23) A Summary of the Four Annual Reports of the Central Sanitary Bureau Attached to The Home Department of the Imperial Japanese Government from 1884 to 1887. Tokyo. 1890.

1885년에 발생했던 콜레라의 경우, 9월에는 나가요 센사이 위생국장을 비롯하여, 당시의 경찰국장과 총리비서실장 등이 특별 위원회를 구성하여 매일 만나 대책을 수립하는데 진력했다.[24] 그럼에도 일본 제국주의자들은 콜레라를 방제하는데 크게 성공하지 못했던 것으로 보인다. 그들이 취할 수 있었던 방제책은 요코하마에서 도쿄 사이를 달리는 열차들을 제한하고 승객들을 철저히 조사하였고 도쿄에는 육로로만 다닐 수 있도록 하는데 그쳤다.[25]

제국주의자들은 위생 사업을 효과적으로 수행하기 위해 적정한 의사 수를 확보하는데에 신경을 쓸 수밖에 없었을 것이다. <표 3>이 보여주듯이, 일제는 이미 1880년대 중반에 의사 1인당 국민 수가 1,000명을 넘지 않을 정도로 의사 인력을 관리하고 있었으며, 제국의 인구 관리를 위해서는 조산원들도 필요했을 것이다.

표 1. 1880년대 중반 일본 제국에 발생했던 전염병 및 감염성 질환의 발생건수와 사망자수[26] (위의 숫자: 발생건수, 아래 숫자: 사망자 수(명))

질병	1884년	1885년	1886년	1887년
콜레라	904 417	13,824 9,329	155,923 108,409	1,228 654
장티푸스	23,279 5,969	29,504 6,672	66,224 13,807	47,449 9,813
이질	22,702 6,036	47,377 10,690	24,326 6,839	16,149 4,257
디프테리아	2,237 1,266	2,798 1,440	3,265 1,465	2,741 1,429
발진티푸스	3,459 445	2,302 365	8,225 1,577	2,487 448
두창	1,703 410	12,759 3,329	73,337 18,676	39,779 9,967
합계	54,284 14,543	108,564 31,825	331,300 150,773	109,833 26,568

대신에 일본 제국주의자들은 전염병의 창궐을 방제하기 위해 예방 접종에 막대한 인력과 비용을 투자하였다. 하지만 <표 2>가 보여주듯이, 이 예방 접종도 항상 성공을 했던 것은 아니었다.

이처럼 위생국은 일본인의 출생과 사망, 결혼 등 기초적인 인구 통계 뿐만 아니라, 각종 질병, 의사 인력 등을 포함하는 통계표를 상세

24) 앞의 보고서. pp.55－6. 그들은 콜레라의 방제를 위해 엄청난 노력을 기울인 것으로 보여진다. 전체 132쪽의 보고서 중에서, 35쪽(pp.48－82)을 콜레라 방제와 관련하여 쓰고 있다.

25) 앞의 보고서. p.57.

26) A Summary of the Four Annual Reports of the Central Sanitary Bureau Attached to The Home Department of the Imperial Japanese Government from 1884 to 1887. Tokyo. 1890. p.29.

표 2. 1880년대 중반 접종 현황[27]

	성공했던 접종자 수	성공하지 못했던 접종자 수	합계
1884년	1,478,931	392,657	1,871,588
1885년	2,609,902	1,575,834	4,325,437
1886년	3,254,129	2,588,218	5,842,447
1887년	1,735,114	1,031,377	3,066,491

표 3. 1880년대 의료 인력[28]

	의사	의사 1인당 국민 수	약제사	조산원
1884년	39,708	949	8,528	20,061
1885년	38,909	973	8,881	27,175
1886년	40,455	950	9,439	28,957
1887년	40,879	956	9,878	29,863

하게 기록하고 있다. 당시 일본에서 살았던 각 개인은, 통계적 절차를 거쳐, 일제가 관리하고 통제하기 위한 권력의 객체로 바뀐다. 통계표를 통해 분류된 각종 항목들 — 출생율, 사망률, 전염병으로 인한 사망률 등 — 은 제국이 자신의 인구 집단을 어떤 규칙에 의해 관리하고 있는지를 보여주는 잣대이다. 위생국이 매년 발간한 보고서의 각종 통계들은 제국이 요구하는, 도덕적 규범이 어느 정도로 충족되고 있는지를 보여주는 숫자일 뿐이다.[29] 제국의 시대에 살았던 각 개인의 몸은 제국에 의해 관리되고 규제되어야 하는 통계적 항목으로 분절화된다. 19세기 유럽의 근대적 위생에 관한 역사가 보여주듯이,[30] 제국은 사회적 몸(social body)[31]을 통제할 수 있는 생체 권력(biopolitics)[32]에 관한 장치들을 확보하고 있어야 한다. 그래야 제국은 자신의 영토를 확장하여 더 많은 식민지로 뻗어 나갈 수 있다. 이제

27) 앞의 보고서. p.96.

28) 앞의 보고서. p.118. 의사 수는 위생국의 1897년도 통계와 조금 차이가 있다.

29) Ian Hacking. How Should We Do the History of Statistics? eds by Graham Burchell, Colin Gordon, & Peter Miller. 앞의 책. pp.181–96을 참고할 것.

30) 이종찬. 근대적 위생론과 사회적 몸: 1830년대–1850년대 영국을 중심으로. 역사와 문화 2003;6:69–91.

31) Mary Poovey. Making a Social Body: British Cultural Formation, 1830–1854. Chicago: University of Chicago Press 1995.

32) Michael Hardt & Antonio Negri. Empire(2000). 제국. 윤수종 옮김. 서울: 이학사; 2001. pp. 51–77.

인구 집단에 관한 각종 통계는 제국의 통치 기술에서 빼놓을 수 없는 분야로 자리를 잡았고, 제국의 인구를 통제할 수 있는 파놉티콘(panopticon)으로서 기능하게 된 것이다.

나가요 센사이의 뒤를 이어 1892년에 고토오 쉰페이(後藤新平, 1857－1929)가 위생국장을 맡으면서 의사, 약사, 조산원과 관련된 각종 시험과 위생 시설에 관한 규제 등이 연간 보고서의 내용으로 포함되었다.[33] 고토오는 독일에서 배웠던 세균학 이론을 도입하여 도쿄, 오사카, 요코하마에 위생 실험실을 1896년에 설치하였으며,[34] 제국의 국민들에게 백신 접종을 대량적으로 수행하기 위해 백신 농장을 같은 해에 가동하기도 했다.[35] 1897년에 고토오는 '역학적' 예방 사업이라는 용어를 채택함으로써 위생 사업의 과학적 근거를 더욱 공고히 하였다.[36] 또한 그는 같은 해에 전염성 및 감염성 질환의 예방에 관한 법률을 제정하였는데, 이 법률의 1조는 콜레라, 이질, 장티푸스, 두창, 발진티푸스, 성홍열, 디프테리아, 페스트의 8개 질병을 전염성 및 감염성 질환에 포함하였다.[37]

1904년 1월 1일자로 위생국장으로 부임한 구보다 세이타로(窪田靜太郞, 1865－1946)의 등장은 일본 제국이 러·일 전쟁을 앞두고 있었다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 그의 부임과 동시에, 위생국과 별도로 중앙보건위원회가 설치되었다. 위원장에 제국의 군의총감(軍醫總監)이었던 이시구로 타다노리(石黑忠悳, 1845－1941)가 임명된 것은, 일본이 국가적으로 전쟁에 대비하여 군사 체제로 전환하였음을 말해준다.[38] 간사인 구보다를 비롯하여 위원으로는 내무성 경찰국장인 아리마추 히데요시(有松英義, 1863－1927)를 포함하여 육군 군의감, 해군 군의감, 동경제국대학 의대 학장 등 참여 인물을 보면,[39] 일제가 전쟁에서 이기기 위해 얼마나 치밀한 준비를 하고 있었는지를 실감나게 한다. 제국의 입장에서 볼 때, 국민 각자의 몸은 전쟁의 승리를 위한 군사적 수단에 불과했다.

한일합방이 되던 해에 위생국이 수행했던 사업에는 흥미로운 점이 눈에 띈다. 메이지 유신 이래로 인정을 받지 못했던 침구사들에 관한 통계 기록이 위생국의 연례 보고서에 포함되어 있다.[40] 여전히 구보다가 위생국장을 맡고 있었던 1910년도에 전체 침구사는 36,821명이었으며, 그 중에 10,432명만 침술업에만 종사했으며, 8,949명은 뜸을 놓는 일만 맡았다. 이로 미루어 볼 때, 일제가 자신의 전통의학을 일방적으로 배격하고 근대적 의료 체계

33) The Annual Report of the Central Sanitary Bureau Attached to The Home Department of the Imperial Japanese Government(이하 Annual Report), 1893－1894. Tokyo: 1897. 이 보고서는 고토 심페이가 물러나고 발간되었다.
34) Annual Report(1896). Tokyo: 1900. pp.10－13.
35) 앞의 보고서. pp.13－5.
36) Annual Report(1898, 1899, 1900). Tokyo: 1909.
37) Central Sanitary Bureau of the Home Department. The Sanitary Laws of Japan. 1911. p.51. 토쿠가와 시대 일본의 전염병에 대해선, Ann B. Jannetta. Epidemics and Mortality in Early Modern Japan. Princeton: Princeton University Press 1987을 볼 것.
38) Annual Report(1904－1905). Tokyo: 1908. p.21.
39) 앞의 보고서. pp.21－2.
40) Annual Report(1910). Tokyo: 1912. p.54.

를 확립하려고 했던 것은 아님을 알 수 있다. 또한 간호사에 대한 통계도 이 때부터 보고서에 기록되고 있는데, 당시 조산원이 27,674명인데 비해 간호사는 11,574명에 불과한 것도 매우 흥미로운 점이 아닐 수 없다.[41]

4. 독일 의학을 모델로 삼았던 제국의 의학자들

일제가 위생과 의학에서 제국주의적 헤게모니를 어떻게 관철해나갔는지를 이해하려면, 당시에 중요한 역할을 했던 세 명의 의학자에 대해 초점을 맞출 필요가 있다.

메이지시대에 과학적 기초를 정립하는데 중요한 역할을 한, 키타사또 쉬바사부로는 1884년에 도쿄대학교를 졸업하고 위생국에서 일했다. 메이지 정부는 제국의 과학자들로 하여금 유럽과 미국으로 유학가는 것을 적극적으로 권장하고 있는 분위기에서,[42] 그도 해외에 나가서 공부할 기회를 찾고 있었다. 메이지 정부는 처음에 키타사또를 당대 최고의 위생학자인 페텐코퍼(Max von Petenkoffer, 1818－1901)가 있던 뮌헨으로 보내려고 했으나, 키타사또는 학문적 이유를 내세워 이 제안을 거절했다. 페텐코퍼는 사회적으로 불량한 위생 상태가 질병을 초래한다고 보았던 반면에, 코흐는 특정한 세균이 질병을 발생시킨다고 보았기에, 키타사또는 페텐코퍼가 있는 뮌헨으로 가는 것은 의학적 연구에 맞지 않다고 주장했기 때문이다. 그의 제안이 받아들여져, 그는 코흐가 있는 베를린으로 가게 되었다. 1889년에 파상풍균을 발견하여 서구 과학계에 학문적 명성을 얻은 후 일본으로 돌아온 그는, 자신의 스승인 코흐가 걸었던 학문적 경로대로, 모교에서 1891년에 제안한 교수직을 거절하고 전염병연구소를 설립하였다.[43] 그는 1908년에 코흐를 일본으로 초대할 정도로, 독일의 세균학을 일본에 정착시키는데 결정적인 공헌을 하였다.[44]

다음으로, 고토오 쉰페이는 페텐코퍼의 지도로 박사학위[45]를 받고 돌아와 나가요 밑에서 근대 의학을 군진 위생에 접목하는 법을 배웠다.[46] 키타사또와 함께 위생국에서 일하면서

41) 앞의 보고서. pp.52－3.

42) 사이먼 플렉스너의 도움으로 펜실베니아에서 공부했던 노구치 히데요시도 이런 시대적 상황이 만들어낸, 세계적인 과학자였다.

43) 코흐는 당시에 자신이 근무했던 베를린 대학과 매우 불편한 관계를 유지했다. 대부분의 동료들이 이학박사(Ph.D.)이었던데 반해, 그는 의학박사(M.D.)였을 뿐만 아니라, 당시 대학에서는 기초의학과 임상의학이 엄격히 분리되었는데도 그는 양자간의 밀접한 연관성을 주장했고, 대학교수들이 학문 연구에만 종사했는데 그는 사회적 활동에도 열심히 관여했기 때문이다. 이런 분위기에 코흐가 대학으로부터 분리된 실험실을 요구하고, 그의 결핵균 실험이 별로 호응을 얻지 못하자, 베를린 대학교수 직을 포기하고 만다. 키타사또는 코흐의 이런 학문적 경향으로부터 영향을 받았던 것이다. James R. Bartholomew. The Formation of Science in Japan: Building a Research Tradition. New Haven and London: Yale University Press 1989. pp.80－2. p.101.

44) M. Miyajima. Biography on Kitasato Shibusaburo. British Medical Journal 1939;1141－2. 1939. 코흐는 6주간 일본에 머물렀다.

45) 학위 논문은 "일본 및 다른 나라들의 醫事警察과 의료행정에 대한 비교 연구"(Verleichende Darstellung der Medizinalpolizei und Medizinalvervaltung in Japan und anderen Staaten)이다.

46) 나가요, 키타사또, 고토 등 일본의 의학자들이 의학과 軍陣 위생을 접목시킨 내용에 대해선, Louis L. Seaman. The Real Triumph of Japan: The Conquest of the Silent Foe. New York: D. Appleton & Co

1883년에 처음 만나 알게되었고 1887년에 독일에서 위생학을 같이 공부했던 고토오는 위생국장을 맡으면서 키따사또가 전염병연구소를 설립하도록 도와주었다.[47] 일제의 만주 침략을 원활히 하기 위해 남만철도회사(南滿鐵道會社)[48]를 설립했던 그는 만주의 발전은 공중위생에 달려 있다고 보았다. 고토오는, 사회의학자 프랑크가 이론적인 체계를 정립했던 의사경찰이 제국의 위학과 위생을 발전시키는데 매우 유효하다고 보았다. 그가 1889년에 발표했던 『국가위생원리』(國家衛生原理)[49]의 정신을 그대로 반영하고 있는, 일본 식민정책학의 창시자라고 일컬어지는 니토베 이나조오(新渡戶稻造, 1862－1933)가 쓴 「의학의 진보와 식민 발전」(醫學の進步と植民發展)[50] 에 담긴 다음 구절은 일제의 '과학적 식민주의' (scientific colonialism)가 의학과 위생에 얼마나 철저히 기초하고 있는지를 잘 보여준다.

> 식민지 경영의 방법이 반드시 위생에 바탕을 두어야 하고, 또 의학의 원조를 받지 않으면 안된다는 것입니다. … 식민지를 경영하는데 그만큼 위생이나 의학의 원조가 필요하다면 본국에서는 두말할 나위 없이 의학을 발전시키지 않으면 안됩니다. 식민지 경영의 근본이라고도 할 수 있는 의술의 연구를 본국에서 게을리 한다면 우리가 해군이나 육군의 힘 그리고 경제의 발전에 의해 얻은 식민지도 물거품으로 돌아갈지도 모른다는 걱정을 하고 있습니다.[51]

니토베와 고토오 등 식민 지배자들에 따르면, 과학적 식민주의는 두 가지를 의미했다. 하나는 식민 정책은 과학적 연구에 근거하여 수립해야 한다는 것이며, 다른 하나는 식민 정책은 피식민지에 과학 문명의 혜택을 가져다 준다는 것이다.[52] 고토오는 메이지 유신 이후 30년만에 일본이야말로 서구 문명을 전유하여 동아시아 사람들의 복지를 향상시킨 유일한 나라로서, '아마도' 독일을 제외하고는 어느 나라도 일본의 의학이 성취한 업적을 따라올 수 없을 것이라고 말했다.[53] 그에 의하면, "의학은 정치적 복지의 열쇠이며, 의사는 근대 문명을 수행하는 사람이다."[54]

대만을 식민화한 후에 3대 총독을 맡았던 고다마 겐타로(兒玉源太郎) 밑에서 민정장관을 지내기도 했던 고토오는 일본에서 '도시 계획의 아버지'로 불리울 정도로, 도시 계획에 풍부한 식견을 갖고 있다. 그의 이런 경험은 만

1908. pp.216－32을 볼 것.

47) James R. Bartholomew. 앞의 책. pp.140－1.

48) 당시 일본의 철도 기술이 서구보다 앞섰다는 논의에 대해선, Arnold Pacey. Techonology in World Civilization: A Thousand－Year History. Cambridge, M.A.: The MIT Press 1990. pp.152－158를 볼 것.

49) 現代日本思想大系. 26卷. 科學の 思想. 東京: 筑摩書房 1964. pp.289－303.

50) 醫學の進步と植民發展(의학의 진보와 식민 발전, 원래 1918년에 씌여졌음). 新渡戶稻造 全集. 弟四卷. 東京: 敎文館. 1969. pp.326－345.

51) 新渡戶稻造. 앞의 글. p.344.

52) Ming－Cheng M. Lo. Doctors within Borders: Profession, Ethnicity and Modernity in Colonial Taiwan. Berkeley: University of California Press 2002. p.5.

53) 日本國會圖書館. 後藤民政長官演說筆記. File no. 7－28－3. 後藤新平文書. Ming－Cheng M. Lo. 앞의 책. p.176에서 재인용.

54) 앞의 後藤新平文書. Ming－Cheng M. Lo. 앞의 책. p.39에서 재인용.

주 뿐만 아니라 타이페이를 개발하는데도 그대로 이용되었다.[55] 고토오는 이런 경험을 토대로 동경 시장까지 역임하였는데, 동경 시장 재직 시에 썼던『강호의 자치제』(江戶の 自治制)[56]는 도시 계획이 포함해야 할 중요 사업들 — 도로, 사회사업, 교육 기관, 상하수도, 주택, 전기, 항만, 하천, 공원 및 광장, 장의 시설, 시장 — 에 대해 일목 요연하게 정리하고 있다.

모리 린타료(森林太郎, 또는 모리 오가이 森鷗外, 1862－1922)[57]는 1881년에 도쿄대학교 의학교를 졸업한 뒤에 군진 병원에 잠깐 근무한 뒤에 1882년에 전쟁성 의사국으로 자리를 옮겼다. 여기서 그는 프러시아의 육군 위생 제도를 조사하는 과제를 맡았는데, 그는 12권 짜리 보고서를 1883년에 마무리하였다.[58] 이후 독일로 가기를 끈기있게 기다리던 그에게 마침내 기회가 왔다. 의사국은 1884년에 그가 독일에서 군진 위생을 배울 수 있도록 허락하였다. 라이프찌히와 드레스덴에서 당시 의학의 최신지견을 섭렵했던 그는 독일 최고의 위생학자로 알려졌던 페텐코퍼가 있던 뮌헨으로 옮겨 왔다. 그가 독일 위생을 배우는 데 어느 정도 열심이었는가 하면, 당시 독일에서 코흐와 페텐코퍼를 둘러싼 위생에 관한 논쟁[59]이 한참 진행되고 있었을 때, 모리는 적극적으로 나서서 자신의 입장을 개진할 정도였다. 모리는 뮌헨에서도 오래 머물지 않고 1887년에 베를린으로 돌아왔다. 당시 프랑스나 영국의 교육 제도와 달리, 독일에서는 학생들이 라이프찌히에서 공부를 시작하여, 뮌헨으로 옮겨서 다음 학기를 이어가고 베를린에서 학업을 마칠 수 있을 정도로 지역간 이동이 허용되었기에,[60] 모리도 이런 과정을 자연스럽게 밟을 수 있었다.

군진 의사로서 모리의 삶은 청·일 전쟁을 통해서 조선과 관계를 갖게 되었다. 전쟁이 발발하자 육군 군의총감의 자격으로 히로시마를 출발하여 1894년 9월에 부산에 들어왔던 그는 일본 군인의 부상을 줄이는 군사 위생의 역할을 맡았다. 한달간 부산에 머물면서, 그는 조선의 도로, 하천, 병원, 질병, 상수도 등 공중 위생에 대한 전반적인 상황을 18차례나 일본에 보고서를 제출하였다.[61] 그리고 요동 반도의 전투에 참여하고 난 후에 잠깐 일본을 다녀온 그는 다시 산동 지방으로 전출받는다. 1895년에 모리 린타료는 일본의 식민지로 편입된 대만의 공중 위생을 관장하는 업무를 수행하고 그 해 10월에 동경으로 다시 귀환하였다.

동경으로 돌아온 모리는 육군 군의학교의 행정과 운영을 다시 맡게 되었고, 2년 간『위생신편』(衛生新編)의 작업에 몰두한 그는 1896

55) Louise Young. Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism. Berkeley: University of California Press 1998. p.248.
56) 東京: 二松堂 1922.
57) 일본 뿐만 아니라 서구에서 그는 문학가로서 알려져 있어서 모리 오가이로 불린다.
58) Richard J. Bowring. Mori Ogai and the Modernization of Japanese Culture. Cambridge: Cambridge University Press 1979. p.8.
59) 당대 독일 최고의 위생학자였던 페텐코퍼는 여전히 장기설을 주장했으며, 코흐는 감염설로 대응했다.
60) James R. Bartholomew. 앞의 책. p.72.
61) 모리 린타료가 청·일 전쟁과 관련하여 수행했던 일에 대해선 James R. Bowring. 앞의 책. p.91을 볼 것.

년에 전반부를 1897년에 후반부를 발간하였는데, 이 책은 당시 일본 군부뿐만 아니라 의학계에도 널리 읽혀져서 1914년까지 무려 5회나 판을 거듭할 정도였다. 원래 이 책의 초판은, 1889년부터 1894년까지 모리 자신이 창간한 「의사신론」(醫事新論)[62]이라는 잡지에 막스 루브너(Max Rubner)가 쓴 『위생의 개요』(Lehrbuch der Hygiene, 1890)을 번역한 내용들을 연재하였는데, 이를 묶어서 펴낸 것이다.[63] 이후, 판을 거듭하면서, 모리는 자신의 연구결과를 추가하였다.

1900년에 발생한 중국 의화단 사건에 참여하고 돌아온 모리 린타료[64]는 의화단을 진압하기 위해 서구 열강들이 연합 군대를 만든 사건을 중세의 십자군 전쟁(1096－1270)에 비유하면서, 서구에서 온 군인들이 중국인을 진압하는 이유가 "부분적으로는 백인의 황색 인종에 대한 증오(黃禍)"에 의한 것으로 보았다.[65] 당시 유럽 사회에서 인종 이론에 대한 선구적 역할을 하고 있었던 프랑스의 고비노(Arthur de Gobineau)가 쓴 『인종의 불평등에 관하여』(Essai Sur l'inegalite des races humanies, 1853－5)를 읽은 모리는 이 책이 유럽 중심적 사고를 보여주고 있다고 비판하면서, 자신의 인종이론을 『황화론편개』(黃禍論 , 1905)와 『인종철학편개』(人種哲學 , 1906)로 출간하였다. 이 책의 발간은, 모리가 러·일 전쟁으로 조선으로 건너와 군진 위생에 관한 전략을 수행했으며 일본의 군사적 요충지였던 만주를 오가면서 만주의 군진 위생에도 깊이 개입하는 등 전쟁 직후에 이루어졌다.

그런데, 여기서 매우 흥미로운 점은 일본학자나 서구학자들이 조선과 만주에서 군진의사로서의 모리 린타료의 역할에 대해 거의 주목하지 않는다는 사실이다.[66] 그는 제국의 군진의사로 자기 역할을 수행하면서도 문학가 또는 문학비평가로서 활발하게 작품을 남겼고, 메이지 시대가 끝나가던 1911년부터 오로지 역사 소설에 매달렸다.[67] 독일에 의학을 공부하러 갔으면서도, 모리는 독일에서 보낸 첫 해에 괴테와 단테의 작품을 포함하여 세계적인 문학 서적을 무려 170권이나 모았다고 한다.[68]

62) 現代日本文學アルバム. 第一卷. 森 鷗外. 東京: 學習研究社 1974. p.142.

63) 942쪽이었던 첫판은 1899, 1904, 1908, 1914년을 거치면서, 거의 두 배로 양이 늘어나 1830쪽이 되었다. 이 책은 군사용과 대학교과서용의 두 가지 판형으로 발간되었다. Richard J. Bowring. 앞의 책. p. 93.

64) 그는 1899년부터 1903년까지 큐슈 북부의 고쿠라 지방의 군의감이라는 다소 한직으로 밀려나 있었는데, 이 때 그는 클라우제비츠가 전쟁에 대해 쓴 유명한 책인, 『戰爭論』(Vom Krige)을 번역하여 1903년에 출간하였다. Richard J. Bowring. 앞의 책. pp.102－3.

65) 앞의 책. p.109.

66) 이는 마치 일본과 서구의 문학비평가들이 나추메 쇼세끼가 영국에서 보낸 삶에만 주목하고 조선과 만주에서 수행했던 활동에 대해 무시하는 것과 일맥상통하다. T. Lamarre. Bacterial Cultures and Linguistic Colonies: Mori Rhintaro's Experiments with History, Science, and Language. positions: east asia cultures critique 1998;6(3): 597－636. p.599.

67) 군진 의사와 문학가로서 이중적 삶을 살았던 그는 문학가로 행세할 때는 모리 오가이, 군진 의사로 행세할 때는 모리 린타료라는 이름을 선호했다. 그럼에도 문학에서 과학적 방법에 대해 비평을 할 때는 모리 린타료라는 이름을 사용했는데, 이 때에도 그는 '의사'로서의 자신을 드러내지 않았다. T. Lamarre. 앞의 글. pp.621－2.

68) D. Dilworth & J.T. Rimer(eds.). The Historical Fiction of Mori Ogai. Honolulu: University of Hawaii

독일에서 읽었던 괴테, 셰익스피어, 쇼펜하우어, 릴케, 쉴러, 푸쉬킨, 고르키, 톨스토이, 투르게네프, 졸라, 루소, 라신, 버나드 쇼 등의 작품들을 귀국 후에 그는 일본어로 번역하는 일에 정력적으로 매달렸다. 이런 번역 작업은, 그가 육군 군의총감으로 일하면서도 또한 이미 그가 작가로서의 명성을 굳힌 뒤에도, 지속되었다는 점에서 매우 흥미롭다.[69] 이렇게 문학과 철학에 대해서 해박한 지식을 섭렵하였던 그는 시, 소설, 희곡 등의 문학 작품, 미학, 전쟁 전략, 의학을 포함한 과학의 다양한 분야에 관한 방대한 기록을 남겼다.[70]

제국의 군진 의사로서 조선을 침략하는데 자기 소임을 다했던 한 사람이 문학가로서 어떻게 일본인의 마음속에 깊이 영향을 미치고 있는 작품을 쓸 수 있었을까? 문학가로서의 모리 오가이와 제국의 군진 의사로서의 모리 린타료의 두 자아가 어떻게 양립할 수 있었을까?[71] 청·일 전쟁과 러·일 전쟁에 참전하였고 대만총독부 육군의 군의부장으로서 대만에서 일어난 반란(1894년)을 진압하는데도 참여했던[72] 모리 린타료가 인생에 대한 자기 성찰을 존재 근거로 삼고 있는 문학가로서의 모리 오가이와 한 인간의 몸 속에서 어떻게 조화를 이룰 수 있었을까? 이런 의문에 대한 대답은 그 자신이 가장 인용하기를 좋아했던 괴테의 다음 글에서 찾을 수 있을 것이다.

> 사람들은 자신을 어떻게 알게 될까? 그것은 결코 사색으로 알 수 있는 것이 아니다. 오로지 행동에 의해서만 알 수 있다. 당신의 의무를 행하도록 노력하라. 그러면 당신은 의무를 통해서 당신을 알게 될 것이다. 무엇이 당신의 의무이냐고? 그것은 시대가 요구하는 것이 바로 당신의 의무이다.[73]

모리 오가이는 시대의 요구를 일본의 제국주의적 팽창이라고 인식했고, 이 의무를 수행하기 위해 모리 린타료라는 군진 의사로서 기꺼이 자신의 의학적 지식을 실천에 옮길 수 있었던 것이다. 이렇게 볼 때, 모리 린타료가 한 인간의 몸에서 모리 오가이로 자아의 변환이 아무런 정신분열증적인 갈등이 없이 일어날 수 있는 것이다.

이상과 같이, 키타사또, 고토오, 모리는 과학적 위생에 관한 이론과 실천 방식을 메이지 통치자들에게 제공하여 제국의 발전에 기여했다는 점에서, 그들은 메이지 제국이 시키는 대로 과학적 연구를 수행했던 의학자가 아니라, '위생의 제국'(empire of hygiene)을 건설하는데 앞장선, 제국주의자들이었다.

5. 세균설과 제국의 몸

메이지 통치자들이 일본 국민들의 몸을 제국주의적 일상 생활의 규범으로 통합시켜 나가는데 있어서 위생과 의학은 필수불가결한 과학적 담론이자 실천 전략이었다. 위생과 의학에 대한 과학적 프로그램을 통해, 한 개인의

Press 1991. p.18.

69) D. Dilworth & J.T. Rimer(eds.). 앞의 책. pp.20－21.

70) 森鷗外. 森鷗外全集. 3版. 38卷. 東京: 岩波書店 1971.

71) T. Lamarre. 앞의 글. p.599.

72) 現代日本文學アルバム. 앞의 책. p.142.

73) J.T. Rimer. Mori Ogai. Boston: Twayne Publishers 1975. p.5.에서 재인용.

몸은 제국의 몸(imperial body)으로 통합되어 갈 수 있었다. 영국과 프랑스 등의 서구 열강들이 인도와 아프리카를 제국의 식민지로 만드는데 중요한 전략으로 채택되었던 과학적 위생과 의학 지식[74]은 메이지 시대 일본인의 근대적 몸을 만들어 가는데 없어서는 안될 도덕적 담론으로 자리를 잡았다.[75]

세균설(germ theory)은 제국의 몸을 만들어 가는데 단순히 과학적 이론으로서 기능했을 뿐만 아니라, 더 나아가서 제국의 이데올로기로서 작용했다. 세균설이 유럽 사회에 1870년대 처음으로 등장했을 때, 의사들보다는 정치가나 사회개혁가들이 더욱 민감하게 반응하였다. 왜냐하면, 당시에 환자를 치료하는데 세균설은 크게 임상적 효과를 나타내지 못했던데 반해, 세균설에 대한 찬성과 반대 여부에 따라, 정치적·사회적 이해관계는 큰 영향을 받았기 때문이다. 서구의 경우, 해외 무역을 통해 제국의 영토를 확대하려고 했던 제국주의자들은 세균설의 등장을 처음에는 달가워하지 않았다. 세균설을 지지하게 되면, 해외 무역은 검역으로 인해 제한을 받아야 했기 때문이다.[76]

하지만, 메이지의 제국주의자들은 서구의 이런 논리를 역으로 이용할 줄 아는 지혜를 알고 있었다. 그들은 세균설에 근거하여 질병의 발생 원인을 개인의 책임으로 전가하는 이념적 공세를 취했다. 특히 사회주의자들이 결핵은 빈곤으로 인해 발생하는 사회적 질환이므로 국가가 책임을 져야 한다고 메이지 정부의 위생 정책에 대해 비판을 해오자,[77] 제국의 위생가들은 이를 개인의 위생 문제로 국한시키는 이념적 입장을 더욱 강화하였다.[78] 세균설은, 메이지 통치자들에게, 질병의 사회적 원인과 국가적 책임을 주장하는 사회주의의 비판을 무력화시킬 수 있는 과학적 이론이었던 것이다.

더 나아가서 메이지 통치자들은 제국의 국민들에게 "질병은 더 이상 개인적 불행이 아니라, 공공의 질서에 대한 도전"[79]이라고 강요하였다. 그래서 세균을 가진 환자들은 제국의 질서를 문란하게 할 위험 인자이므로, 제국의 몸을 건강하기 위해선 철저한 검역이 필요하였다. 메이지 초기에는 이렇게 세균이 많은 비위생적인 인구 집단 – 조선 사람들도 여기에 속했다 – 과 건강한 제국의 국민을 분리하는 정

74) David Arnold. Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-century India. Berkeley and Los Angeles: University of California Press 1993; Andrew Cunningham and Bridie Andrews. Introduction: Western medicine as Contested Knowledge. eds by idem. Western Medicine as Contested Knowledge. New York: Manchester University Press 1997.

75) **도덕적 담론으로서의 위생에 대해선** Allan M. Brandt & P. Rozin(eds.). Morality and Health, London: Routledge, 1997; Lupton, D. The Imperative of Health: Public Health and the Regulated Body. London: SAGE 1995**을 볼 것.**

76) E.H. Ackerknecht. Anticontagionism between 1821-1867. Bulletin of the History of Medicine 1948;22:562-593; Sylvia N. Tesh. Hidden Arguments: Political Ideology and Disease Prevention Policy. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press 1988. pp.7-32.

77) M. Bourdaghs. The Diseases of Nationalism, the Empire of Hygiene. positions: east asia cultures critique 1998;6(3):637-673. p.645.

78) William Johnston. **앞의 책**. pp.189-213.

79) Bruno Latour. Les Microbes: guerre et paix; suivi de Irreduction(1984). The Pasteurization of France. translated by A. Sheridan and J. Law. Cambridge: Harvard University Press 1988. p.123.

책을 실시했던 제국주의자들은 메이지 후기에는 전자의 인구들을 제국의 국민으로 통합하는 정책으로 방향을 선회하였다.[80] 검역 위주의 위생 정책이 예방 접종 중심으로 바뀌게 된 것이다. 러·일 전쟁에서 승리한 후로 조선에 대해 실제적인 지배자가 되었음에도 메이지 통치자들은 조선을 어떤 방식으로 통치할 것에 대해 의견이 갈렸다.[81] 결국 을사조약(1905)이라는 단계적 절차를 거친 후에 '내선일체'(內鮮一體)를 내세워 조선을 합병한 한 것은, 조선 사람들을 제국의 몸으로 만들어가기 위해선 합병이 더욱 효과적이라고 판단했기 때문일 것이다. 접종(vaccination)은 민족을 보호(vacci－Nation)하기 위한 의학적 전략인 셈이다.

모리, 키타사토, 고토오와 같이 독일에서 근대 세균학을 공부했던 제국의 과학자들은 실험실에서 배양하는 균주(colony)를, 조선이나 대만과 같은 일제의 식민지(colony)에 견주었을 것이다.[82] 과학자가 균주의 생물학적 특징을 이용하여 자신의 실험 목적을 달성하듯이, 식민통치자들도 식민지의 모든 인력과 자원들을 착취하여 제국의 이익을 극대화하려고 한다. 조선과 대만은 일제의 식민통치자들에겐 제국을 위해 존재하는 '실험실'에 불과했다. 이렇듯, 그들은, 윌리엄 블레이크(William Blake)가 말했던 것처럼, 제국의 기초로서 과학의 역할을 꿰뚫고 있었다. "제국의 기초는 예술과 과학이다. 만일 그것들을 제거하거나 격을 낮추면, 제국은 존재하지 않는다. 제국이 예술(과 과학)을 따르는 것이지 … 예술(과 과학)이 제국을 따르는 것은 아니다."[83]

6. 러·일 전쟁과 군진 위생

러·일 전쟁(1904－1905)에서 일본이 승리하여 '동양의 이상'[84]을 실현시킬 수 있는 가능성이 더 한층 높아졌을 때, 미국은 불과 50년 전만 해도 자신의 함대 앞에서 무릎을 꿇었던 일본이 승리한 원인을 다각도로 분석했을 것이다. 당시 미국의 장군으로서 일본군의 허락을 받아 전쟁에 참여함으로써 일본군을 국외자의 입장에서 관찰할 수 있었던 루이스 시만(Louis L. Seaman)은 전쟁 직후 바로 썼던 일종의 참전기에서 일본의 승리를 "조용한 적"에 대한 승리로 간주했다.[85] 미국과 스페인 사이의 전쟁, 미국과 필리핀의 전쟁, 중국의 의화단 사건에도 참여했던 시만 장군은 3년 후에 러·일 전쟁에 대해 분석적인 저서인, 『일본의 진정한 승리』(The Real Triumph of Japan)를

80) M. Bourdaghs. 앞의 글. pp.661－2.

81) Marius B. Jansen. The Making of Modern Japan. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press 2000. p.443.

82) M. Bourdaghs. 앞의 글. p.620.

83) Edward Said. Culture and Imperialism(1993). 문화와 제국주의. 김성곤·정정호 옮김. 서울: 창; 1995. pp 221에서 재인용. 괄호안은 필자가 첨가한 것이다.

84) 오카쿠라 텐신(岡倉天心, 1862－1913). 동양의 이상. 최원식, 백영서 엮음. 동아시아인의 '동양' 인식: 19－20세기. 서울: 문학과 지성사; 1997. pp.29－35. 오카쿠라는 원래 영어로 책을 썼다. Okakura Kakasu(오카쿠라의 영어 이름), The Ideals of East with Special Reference to the Art of Japan. 2nd ed. London: John Murray 1904. 이 영어 책의 첫 페이지는 "아시아는 하나다"로 시작하고 있다.

85) 그가 말한 '조용한 적'은 질병을 뜻했다. Louis L. Seaman. From Tokio through Manchuria with the Japanese. New York: D. Appleton and Company 1905.

출간하여, 그는 일본 승리의 원인으로 세 가지를 손꼽았는데, 그 중의 하나로, "많은 의사들이 실용적인 위생을 적용할 줄 알았으며, 군대 내의 예방 가능한 질병들을 박멸"하였기 때문이라고 보고하고 있다.[86] 이 책은 1900년대 후반 미국 정계뿐만 아니라, 미국의 군사 전문가들에게도 널리 읽혀졌는데, 이 책은 일본이 근대 의학의 성과를 군진 위생에 얼마나 철저하게 적용하여 군사력을 향상시켰는지를 설득력 있게 보여주고 있다. 또한 미국 해군의 군의관이었던 브라이스테드(William C. Braisted)도 일본 해군이 군진 위생을 어떻게 관리하고 있는지를 분석하여 상부에 보고하였다.[87]

일본의 군진 위생이 특히 관심을 끄는 이유는, 청·일 전쟁에서 러·일 전쟁까지 불과 10년만에 일본군의 사망률 구성 비율이 완전히 바뀌었기 때문이다. 전자의 경우, 일본군의 환자가 부상자보다 무려 8배나 많았던데 반해서, 후자에서는 거의 1 대 1로 비율이 같아지게 된다.[88] 이런 비율은 영·불 전쟁, 스페인 전쟁, 보어 전쟁 등 다른 서구의 다른 전쟁들과 비교하더라도 세계적으로 유례를 찾아볼 수 없을 정도라고 시만은 말하고 있다. 또한, 일본군이 전쟁 중 부상으로 사망한 경우와 질병으로 인해 죽은 경우의 비율이 4.5 대 1로 서구의 전쟁들과 비교할 때 비율은 완전히 역전 현상을 보여준다.[89] 더욱 놀라운 점은, 전쟁에서 질병으로 죽은 경우에도, 대부분의 경우 전염병으로 인해 죽었지만, 러·일전쟁에서 일본군은 단지 3.51 퍼센트만이 전염병으로 사망했다는 점이다.[90] 아울러, 영양 결핍으로 당시에 흔했던 각기병 조차도 일본 해군에서는 완전히 사라졌다는 사실은 일본군의 위생 시스템이 얼마나 철저하게 작동하고 있었는지를 잘 보여준다.[91] 이렇게 시만은 일본군의 사망과 부상에 대한 각종 통계를 보여준 후에 다음과 같이 결론적으로 맺고 있다.

> 이상의 통계에서 보듯이, 육군에서 질병에 걸린 군인과 부상자의 45 퍼센트가 실제로 전쟁터로 복귀하여 전쟁 업무에 종사하고 있으며 육군의 35 퍼센트 이상이 전체 전쟁 기간 중에 한번도 일과 업무를 빼먹지 않았다는 것은 역사상 유례가 없을 정도로 경이적인 기록이다.

일본군의 이런 경이적인 기록이 나오게 된 과정을 이해하려면, 일본군의 위생 시스템을 먼저 살펴볼 필요가 있을 것이다. 당시 일본군인의 몸은 '싸우는 기계'였다. 몸의 주인은 자신이 아니라 일본 천황이다. 그는 단지 천황의 아이에 불과한, 일본군을 구성하는 한 요소일 뿐이다. 천황을 보위해야 하는 기능을 성실히 수행하려면, 그의 몸은 항상 최상의 상태로 유지되어야 한다. 만일 그가 부주의하여 자신의 임무를 수행하지 못하게 되면, 이는 천황에

86) Louis L. Seaman. The Real Triumph of Japan: The Conquest of the Silent Foe. New York: D. Appleton & Co. 1908. p.1. 다른 두 가지 이유는, "전쟁을 충분히 준비하고 조직했으며, 일본군이 몸에 쉽게 소화될 수 있는 정량의 음식을 먹었기" 때문이다.

87) William C. Braisted. Report on the Japanese Naval Medical and Sanitary Features of the Russo-Japanese War to the Surgeon-General, U.S. Navy. Washington, D.C.: Government Printing Office 1906.

88) Louis L. Seaman. 앞의 책, pp.99-101. 정확하게는 50.1(환자) 대 49.9(부상자)이다.

89) 앞의 책. p.101.

90) 앞의 책. p.102.

91) 앞의 책. pp.233-53.

대한 충성을 거역하게 되는 것이다.[92]

천황에 충성할 수 있도록 일본군인의 몸을 항상 강건하게 만드는 업무를 맡은 사람이 바로 군의관이다. 하지만, 시만은 여기서 일본군의 군의관은 독일과 그 영향권에 있는 나라를 제외한 유럽과 미국의 군의관들과 본질적으로 다르다고 주의를 준다. 일본군의 군의관은 일본군의 위생과 환경에 대해 총체적인 지휘권을 갖고 있으며 어느 누구도 이에 대해 반대를 하지 못한다. 그는 미국과 몇몇 유럽 나라의 군의관들처럼 전염병을 예방하고 환자와 부상자를 치료하는 업무는 물론이거니와, 군대의 의식주와 군인들의 일상적인 생활 습관과 오락 생활까지 관장한다. 예를 들면, 우선 전쟁터에 나가면 군인들이 마실 있는 식수원을 찾아내고 음식의 섭취 가능성을 판단하는 것은 기본 업무에 속했고 군인들이 이동할 수 있도록 도로 및 교통 환경까지 맡아야 했다. 또한 군의관은 일본군이 신는 군화가 전쟁을 수행하는데 얼마나 효과적인지를 평가하고 지형에 따라 다른 유형의 군화가 필요하다면 이를 연구하여 만드는 업무까지 맡았다. 군인들이 입는 피복도 마찬가지였다. 더 나아가서 그는 군인의 정신적 위생과 복지까지 세밀히 관찰해야 했다.[93] 위생과 환경에 관한 이상의 지침들을 군인들 각자가 숙지할 수 있도록 간편한 지침서를 만들어 배부하였다. 이 지침서는 몸의 청결, 의류의 위생 상태, 음식의 섭취 방법, 보행과 이동시의 자세, 진영에서 지켜야 할 규칙, 전염병의 예방 등에 대해 아주 상세히 밝히고 있다.[94] 당시 일본 해군의 군의감이었던 타가키 켄칸은 음식의 중요성을 강조하였다. "음식은 군진 위생에서 제일 중요한 주제이다. 양질의 음식을 충분히 섭취한 군인이야말로 그들이 비위생적인 장소에 살거나 또는 의류가 부족하거나 또는 적당한 주거지가 부족하더라도 강건함과 효율성을 유지할 수 있다."[95] 특히 재미있는 항목은, 중국과 조선에서 난방은 일산화탄소를 배출하므로 매우 위독하다고 경고하고 있다.[96]

이렇게 군의관의 일상적인 업무는 '싸우는 기계'로서의 일본군의 몸이 여하히 전쟁에서 효과적으로 싸울 수 있도록 다양하였다. 그는 "위생전문가로서, 일차 의료를 담당하는 의사로서, 수술을 할 줄 아는 외과 의사로서, 세균학적 실험을 수행할 수 있는 과학자로서, 여러 가지 의료 장비를 다룰 줄 아는 의료 기사로서,"[97] 지금의 현대 사회처럼 노동 분업이 이루어진 사회라면 몇 사람이 해야 할 일에 대해 전문적인 지식과 실무 경험을 갖고 있어야 한다. '군사적 몸'(militarized body)을 최상의 상태로 유지하는 것이야말로 천황에 충성하는 것이다. 이런 개념은 프랑크가 이론적으로 집대성했던 의사경찰을 계승한 에드워드 라이히(Edward Reich, 1836－1919)가 『위생체계』(System der Hygiene, 1870－71)[98]에서 근대적

92) 앞의 책. p.143.
93) 앞의 책. pp.153－71.
94) William C. Braisted. 앞의 책. pp.76－81; B.K. Takaki. Military Hygiene of the Japanese Army. New York Medical Journal 1906(June 9);1－22. pp.6－22.
95) B.K. Takaki. 앞의 글. p.3.
96) William C. Braisted. 앞의 책. p.78.
97) Louis L. Seaman. 앞의 책. p.148.
98) George Rosen. 앞의 글. pp.143－6.

위생론의 개념으로 범주화했던 정신위생, 사회위생, 영양위생, 경찰위생을 모두 포괄하여 군진 위생에 적용한 것이라고 볼 수 있다.

1854년에 처음으로 군진 위생에 관한 책이 발간되면서 그 중요성을 인식하고 있었던 일본 정부는 이후로 요코하마, 오사카, 도쿄 등에 군대병원을 만들게 되고 1871년에 군의학교가 설립되고 1874년에 해군이 독자적인 의과대학을 설립하였다. 이후 일본은 청대 말기에 의화단 사건(1900)이 발생하자 시찰단을 파견하여 서구 열강들의 군진 위생에 대해 세밀하게 분석하여 러·일 전쟁에 대비했던 것으로 보인다.[99] 고토오 쉰페이는 일본의 군진 위생을 체계화하는데 가장 큰 역할을 했는데, 그는 일단 전쟁에 참전했던 군인들이 국내로 들어오면, 히로시마 지역의 니노시마 섬에 있는 검역소에서 엄격한 검역 절차를 밟게 했다.[100] 당시 일본의 의학 교육에서 군진 위생은 아주 중요한 위치를 차지하고 있었어, 의과대학을 졸업하고 군의관이 되면 군의학교에서 6개월간 군진 위생에 대한 과목을 수강한 후에 실무경험을 익혀야 했다.[101]

러·일 전쟁에서 일본의 군진 위생은 이처럼 군사력을 극대화하는데 실제적으로 중요한 역할을 맡았다. 제국의 의학자들은 제국의 팽창을 위해 필연적으로 수반되었던 군사력을 증강하는데 근대적 위생을 전략적으로 활용하였다.

7. 맺음말: 연구의 한계와 앞으로의 과제

메이지 통치자들은 서구적 근대를 좇아가기 위해 근대적 위생 전략을 절실히 필요로 했다. 그래서, 독일에서 발달하고 있던 과학적 세균학을 공부하고 돌아온 메이지 의학자들은 이에 근거하여 먼저 일본인의 몸을 제국적 요구에 맞도록 정책과 제도를 만들어 나갔다. 더 나아가 제국의 확대를 위해 필수불가결했던 전쟁에서 승리하려면, 러시와 같은 다른 제국보다 발달된 군진 위생 인력과 자원을 확충해야 했다. 이렇게 메이지 일본에서 근대적 위생은 제국의 완성을 위한 전략으로서 중요한 위상을 차지했다고 볼 수 있다.

그런데, 이런 논의에서 당연히 제기될 수 있는 문제는, 메이지의 통치자와 의학자들이 과학적 세균설에 근거한 근대적 위생 정책을 만들고 제도를 실시하였던 과정이 당시 일본의 질병관과 어떤 관계를 맺고 있었을까 하는 점이다. 다시 말해서, 메이지 시대 일본의 위생 문화와 일본인의 의식이 과학적 세균설에 근거한 근대적 위생론에 대해 저항하지 않고 이를 받아들일 수 있었던, 질병관의 문화사가 밝혀진다면, 메이지 시대 근대적 위생의 형성과정에 대한 역사적 이해는 질적으로 더욱 깊어질 것이다. 이런 문제를 제기하는 이유는, 메이지 시대 근대적 위생의 형성과정에 대한 역사적 서술이 자칫하면 통치자들과 의학자들 중심의 행위자 중심으로 흐를 가능성이 크기 때문이다.

그래서, 앞으로 이 분야에 관심을 갖게 될 연구자를 위해, 나는 일본 바쿠후(幕府) 정권에 의해 공식적으로 인정을 받은 최초의 서양

99) Louis L. Seaman. 앞의 책. pp.148－9.
100) 앞의 책. p.229.
101) 앞의 책. pp.229－30. 일본 해군의 군의학교 운영 규칙 1조에는 위생에 관한 시험을 반드시 통과하도록 되어 있었다. William C. Braisted. 앞의 책. p.40.

의사였던 폰 미르더보르트(Johannes Pompe van Meerdervoort, 1829－1908)의 이야기를 소개하려고 한다. 그는 콜레라 전염병이 발생하였을 때 유럽인들과 일본인들의 태도를 비교하고 있다. 유럽에서 1832년에 콜레라가 발생하을 때, 성 페테스부르그에서는 주민들이 전염병의 발생을 의사들의 탓이라고 보고 의사들을 강물에 빠트리려고 하는 바람에 짜르 정부가 가까스로 말린 적이 있었으며 파리에서는 의사들이 센느 강물에 익사한 채로 발견되었다는 것이다. 그럼에도 자신이 일본에서 머무는 동안 콜레라가 발생했지만, 일본인들은 유럽 사람들처럼 의사들에게 그런 행동을 하지 않았다고 하면서, "일본 사람들이 보다 문명화된 유럽 사람들보다 자제력을 보여주었다"고 평가하였다.[102]

일본 정부의 환대를 받았던 폰 미르더보르트가 기술하고 있는 일본인의 위생 의식과 상태가 다소 과장되었다고 볼 수도 있겠지만, 그의 서술은 16세기에 일본에 건너왔던 포르투갈과 스페인의 선교사들이 일본인들에게 받았던 깨끗한 이미지와 동심원을 이루고 있다. 특히, 폰 미르더보르트가 서술했던 일본 사람들의 콜레라에 대한 자제력은 전염병에 대한 그들 나름대로의 세계관에 기초한 것이었다. 그가 머물렀던 시기인 1858년과 1859년에 수십만 명의 일본인들이 콜레라로 죽어갔다. 도쿠가와 막부는 콜레라 전염병의 확산을 막기 위해, 영국, 프랑스, 미국 등 서구 나라들의 배를 타고 일본에 온, 콜레라에 감염된 사람들에게 검역을 하려고 했지만, 이들 나라들이 협조를 하지 않아 실패하고 말았다. 당시 서구 사회는 전염병의 원인을 둘러싸고, 보수적 정치가들과 의사들이 지지했던 감염론(contagionism)과 해외 무역으로 경제적 부를 누리고 있었던 신흥 중상주의자들이 지지하고 있던 장기론(miasmatism)이 서로 대립되어 있었는데, 일본이 검역을 하게 되면 서구 나라들은 경제적 이익이 감소될 것을 두려워했기 때문이다. 비록 당시의 일본은 서구와의 의학적 교류가 제한되어 있었지만, 그들은 대부분의 유럽과 미국인들과 달리, 콜레라는 검역을 통해 확산을 방지할 수 있다는 앞선 생각을 갖고 있었다.[103] 폰 미르더보르트의 이야기대로라면, 메이지 이전의 일본 사회는 이미 서구 보다 앞서서 근대적 질병관의 토양이 만들어져왔다고 볼 수 있다.

이처럼, 메이지 시대 근대적 위생에 대한 앞으로의 연구에서 밝혀져야 할 점은, 제국의 통치자들이 수용했던 독일 의학과 같은 근대적 위생론이 일본 사회의 질병관과 어떻게 접목할 수 있었는지를 탐구하는 것이다.

색인어 : 메이지(明治), 위생, 근대성, 제국, 독일

102) Johannes Pompe van Meerdervoort. Doctors on Desima. Pompe van Meerdervoort's Vijf Jaren in Japan(Five Years in Japan, 원래 발행년도는 1867년). Tokyo: Sophia University 1970. p.102.

103) William Johnston. 앞의 책. pp.164－5.

= ABSTRACT =

The Making of Hygienic Modernity in Meiji Japan, 1868 – 1905

LEE Jong – Chan*

This article is based on conceptual and methodological understanding of hygienic modernity in the nineteenth – century Western countries: one is the concept of modern hygiene in the context of modern state and the other is methodological relation of modern hygiene to scientific theory of germ. While modern state calls for the institutionalization of medical police as an administrative tool for consolidating the governmentality what Michel Foucault calls, scientific 'invention' of germ may be considered as 'logical, philosophical and historiographical.' Furthermore, the Meiji medicine men preferred Koch's to Pasteur's laboratory framework, not because the former was scientific than the latter but because Koch's programs were more compatible with imperial needs.

The objective of this paper is to investigate four ways in which hygienic modernity had been established in Meiji Japan; (i) how Meiji imperialists perceived and managed to control Japanese hygienic condition, (ii) how Meiji – leading doctors learned about the German modern system of hygiene to consolidate Meiji empire; (iii) how modern germ theory functioned as the formation of imperial bodies in Meiji period; and (iv) how modern military hygiene contributed to Japanese defeat of Russia.

Although I try to contend that modern hygiene was adopted as one of the most significant strategies for intensifying and extending the Meiji empire, this paper has some limits in not identifying how Japanese perception of infectious diseases were culturally adaptive to science – based hygienic programs the Meiji administrators had installed.

Key Words : Meiji, Hygiene, Modernity, Empire, Germany

---

* *Department of Medical Humanities and Social Medicine, Ajou University*
Department of the History of Science, Harvard University